Freud S. (1940) Compendio di psicoanalisi. In *Opere vol. 11*. Bollati Boringhieri pp. 579-583

Capitolo 3

Lo sviluppo della funzione sessuale[1]

Stando alla concezione corrente, la vita sessuale umana consiste essenzialmente nell'anelito a mettere i propri genitali in contatto con quelli di una persona dell'altro sesso. Baciare, rimirare e toccare questo corpo estraneo ne sono manifestazioni accessorie e atti preliminari. Tale anelito dovrebbe comparire con la pubertà — nell'età dunque della maturità sessuale — e mettersi al servizio della procreazione. Tuttavia sono noti da sempre alcuni fatti che non rientrano nei limiti angusti di questa concezione: 1) è singolare che esistano persone le quali si sentono attratte soltanto da individui del proprio sesso e dai loro genitali; 2) è altrettanto singolare che esistano persone le cui voglie si manifestano in tutto e per tutto come voglie sessuali, prescindendo però dagli organi sessuali o dal loro normale impiego. Sono questi i cosiddetti "pervertiti"; 3) è sorprendente infine come alcuni bambini — che per questo sono ritenuti degenerati — manifestino molto precocemente un interesse per i propri genitali, accompagnato da visibile eccitamento.

È comprensibile che la psicoanalisi abbia provocato sensazione e opposizione quando, proprio in parte rifacendosi a queste tre neglette circostanze, ha contraddetto tutte le opinioni correnti sulla sessualità. Ecco le sue scoperte principali:

a) La vita sessuale non ha inizio soltanto con la pubertà, ma si instaura con manifestazioni evidenti poco dopo la nascita.

b) Bisogna distinguere nettamente fra i due concetti di sessuale e genitale. Il primo è piú ampio e comprende molte attività che non hanno nulla a che fare con i genitali.

c) La vita sessuale comprende la funzione di ottenere piacere da

[1] [La versione originale di questo capitolo era piú stringata. Vedi sopra l'Avvertenza editoriale a p. 569.]

determinate zone del corpo; successivamente tale funzione è posta al servizio della procreazione. Spesso queste due funzioni non sono perfettamente coincidenti.

L'interesse principale si concentra, com'è ovvio, sulla prima affermazione, che è di tutte la piú inattesa. È stato dimostrato che nei piú lontani anni di vita del bambino esistono indizi di attività corporea cui solo un vecchio pregiudizio ha potuto negare l'appellativo di "sessuale", attività collegate a fenomeni psichici che troviamo in seguito nella vita amorosa delle persone adulte, come per esempio la fissazione a determinati oggetti, la gelosia e via dicendo. È stato inoltre dimostrato che questi fenomeni che sorgono nella piccola infanzia seguono un decorso evolutivo governato da leggi ben precise, si intensificano regolarmente fino a raggiungere il loro apice verso la fine del quinto anno di vita, cui succede poi una pausa di tranquillità. Durante questa fase non c'è progresso, molte cose vengono disimparate e si fanno dei passi indietro. Una volta trascorso questo periodo, che è chiamato epoca di latenza, con la pubertà la vita sessuale riprende, o, come potremmo dire, rifiorisce. Ci imbattiamo qui in un dato, l'*inizio in due tempi* della vita sessuale, che non è riscontrabile se non fra gli esseri umani, e che, palesemente, ha una grande importanza ai fini dell'ominazione [vedi sopra, pp. 397 sg.].[1] Il fatto che gli eventi di questa prima epoca della sessualità, a eccezione di alcuni residui, siano soggetti all'*amnesia infantile*, non è affatto privo di rilievo. Le nostre vedute sull'etiologia delle nevrosi e la nostra tecnica della terapia analitica si riallacciano a queste concezioni. L'aver seguito i processi di sviluppo di questa prima età ci ha consentito di verificare anche altre nostre asserzioni.

Il primo organo che si presenta come zona erogena e avanza alla psiche una richiesta libidica è, fin dalla nascita, la bocca. All'inizio ogni attività psichica è preposta a procurare soddisfacimento ai bisogni di questa zona. Essa serve naturalmente in prima istanza all'autoconser-

[1] Confronta in proposito l'ipotesi che l'uomo discenda da un mammifero che a cinque anni avrebbe raggiunto la maturità sessuale. Un qualche immane influsso esterno sulla specie avrebbe poi disturbato lo sviluppo rettilineo della sessualità. Altre trasformazioni nella vita sessuale umana — paragonata a quella degli altri animali — potrebbero essere messe in relazione con questa ipotesi: cosí, per esempio, il venir meno della periodicità della libido e l'utilizzazione del ruolo della mestruazione nella relazione tra i sessi. [L'ipotesi di un rapporto tra epoca di latenza ed era glaciale era stata formulata per la prima volta da S. Ferenczi, *Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes*, Int. Z. (ärztl.) Psychoanal, vol. 1, 124 (1913); Freud l'accettò con una certa cautela in *L'Io e l'Es* (1922) p. 497 e poi, con maggiore convinzione, in *Inibizione, sintomo e angoscia* (1925) p. 302. Sul venir meno della periodicità organica della funzione sessuale vedi *Il disagio della civiltà* (1929) pp. 588 sg., n. 1 e 595 sg., n. 2.]

vazione attraverso il nutrimento; ma non è lecito scambiare la fisiologia con la psicologia. Assai per tempo, nella caparbia ostinazione con cui il bambino continua a ciucciare si palesa un bisogno di soddisfacimento che, nonostante provenga e sia stimolato dall'assunzione del cibo, persegue tuttavia il piacere indipendentemente dalla nutrizione; per questo motivo deve e può esser chiamato *sessuale*.

Già durante questa fase orale compaiono isolatamente, con i primi denti, alcuni impulsi sadici, i quali hanno una parte molto piú ampia nella seconda fase, che chiamiamo sadico-anale, giacché in essa il soddisfacimento è cercato nell'aggressione e nella funzione dell'escrezione. Il diritto che ci arroghiamo di riferire alla libido le tendenze aggressive è fondato sull'idea che il sadismo sia un impasto pulsionale di tendenze meramente libidiche con altre tendenze meramente distruttive, impasto che da quel momento in avanti non cesserà mai piú di esistere.[1]

La terza fase è nota come fase fallica; come fase in un certo senso precorritrice, essa è già assai simile alla configurazione definitiva della vita sessuale. È da notare che in essa non hanno una funzione i genitali di entrambi i sessi, ma solo il genitale del sesso maschile (*phallus*). Il genitale femminile rimane sconosciuto per molto tempo: i bambini, nel loro tentativo di comprendere i processi sessuali, rendono omaggio alla venerabile teoria della cloaca, che ha invero una sua giustificazione genetica.[2]

Con la fase fallica e nel corso di questa la sessualità della piccola infanzia raggiunge il suo apice e si approssima al tramonto. I destini del bambino e della bambina d'ora in avanti si separano. Entrambi hanno incominciato a mettere la loro attività intellettuale al servizio dell'esplorazione sessuale, entrambi partono dal presupposto che il pene sia presente ovunque. Ma le vie dei sessi ora si dividono. Il maschietto entra nella fase edipica, incomincia a manipolare il pene e contemporaneamente elabora fantasie di una qualche attività sessuale del pene sulla madre, fino a quando, per l'azione congiunta di una minaccia di evirazione e della visione della mancanza del pene nella donna, subisce il piú grande trauma della sua vita, che dà avvio al-

[1] Nasce il problema se il soddisfacimento di moti pulsionali meramente distruttivi possa essere avvertito come piacere, se esista la distruttività allo stato puro, senza apporti libidici. Il soddisfacimento della pulsione di morte che permane nell'Io non sembra provocare sensazioni di piacere, benché il masochismo sia un impasto perfettamente analogo al sadismo.

[2] Sono stati segnalati piú d'una volta precoci eccitamenti vaginali; con ogni probabilità si tratta però di eccitamenti alla clitoride, dunque a un organo analogo al pene. Non è quindi messo in dubbio il nostro diritto di chiamare fallica questa fase.

l'epoca di latenza con tutte le sue conseguenze. La bambina, dopo essersi sforzata invano di fare come il bambino, si rende conto della propria mancanza di pene, o meglio della propria inferiorità clitoridea, con conseguenze non effimere sullo sviluppo del suo carattere; in seguito a questa prima disillusione nella rivalità col bambino, sovente ella reagisce cominciando a distaccarsi dalla sessualità in genere.

Sarebbe fuorviante credere che queste tre fasi si susseguano semplicemente una all'altra; è vero piuttosto che una compare in aggiunta all'altra, che si sovrappongono, che coesistono insieme. Nelle fasi piú antiche le pulsioni parziali perseguono il piacere una indipendentemente dall'altra, nella fase fallica appaiono invece i primi indizi di un'organizzazione che subordina le altre tendenze al primato dei genitali e che ha il significato di un primo coordinamento della tendenza generale al piacere nella funzione sessuale. L'organizzazione piena è raggiunta soltanto con la pubertà in una quarta fase, quella genitale. Si è cosí prodotto uno stato in cui: 1) alcuni degli antichi investimenti libidici si sono conservati; 2) altri vengono inglobati nella funzione sessuale come atti preparatori e di sostegno, e il loro soddisfacimento dà luogo al cosiddetto "piacere preliminare"; 3) altre tendenze, escluse dall'organizzazione, o vengono represse assolutamente (rimosse), o sono impiegate nell'Io in un modo diverso, dando luogo a certi tratti del carattere o subendo sublimazioni con relativo spostamento di meta.

Questo processo non sempre si compie in maniera ineccepibile. Le inibizioni del suo sviluppo si manifestano nei piú svariati disturbi della vita sessuale. Si producono allora fissazioni della libido a stadi che appartengono a fasi piú antiche, il cui impulso, che nulla ha a che fare con la normale meta sessuale, è detto *perversione*. Una di queste inibizioni evolutive è, per esempio, l'omosessualità manifesta. L'analisi è in grado di dimostrare che un vincolo oggettuale omosessuale è stato presente in tutti i casi e che nella maggioranza di essi è rimasto allo stato *latente*. La situazione è complicata dal fatto che, di norma, i processi indispensabili affinché si produca un esito normale né si compiono appieno, né sono assolutamente assenti, bensí si svolgono *parzialmente*, talché la configurazione definitiva rimane dipendente da queste relazioni quantitative. L'organizzazione genitale in questo caso è dunque raggiunta, ma soffre per la mancanza di quelle componenti libidiche che non hanno percorso il cammino per intero, essendo rimaste fissate a oggetti e mete pregenitali. Questo indebolimento si manifesta nella tendenza della libido, nel caso di man-

cato soddisfacimento genitale o di difficoltà effettive, a ritornare ai precedenti investimenti pregenitali (*regressione*).

Durante lo studio delle funzioni sessuali abbiamo potuto acquisire un primo provvisorio convincimento, o meglio un presagio, di due scoperte destinate a rivelarsi assai importanti per il nostro campo nel suo insieme. La prima è che i fenomeni normali e anormali da noi osservati, cioè la fenomenologia del nostro argomento, esigono una descrizione dal punto di vista dinamico ed economico (nel caso nostro dal punto di vista della ripartizione quantitativa della libido); in secondo luogo, che l'etiologia dei disturbi da noi studiati va ricercata nella storia evolutiva dell'individuo, dunque nei primi anni della sua vita.